ICOPE · Integrated Care for Older People

長者量六力共學活動講義

微觀看個案 × 宏觀看數據

主辦單位
基隆市衛生局

協辦單位
台灣生活復能健康促進協會

專家委員
長庚科技大學 倪麗芬 副教授

主持人
鍾孟修 職能治療師

掃描開啟網頁版講義

網頁版有互動圖表與「單位自我診斷計算器」，會後可隨時查看。

mattsue1003.github.io/icope-colearning

A 認知
3 項物品記憶・時間與地點定向
☐是☐否

B 行動
雙手抱胸起立坐下 5 次，是否大於 12 秒
☐是☐否

C 營養
3 個月內體重無意減輕 3 公斤・食慾不振
☐是☐否

D 視力
WHO 簡單視力圖・遠／近距離
☐是☐否

E 聽力
氣音測試 6・1・9／2・5・7
☐是☐否

F 憂鬱
過去兩週心煩、沒希望・活動興趣減少
☐是☐否

一、開場
議程・分組・進行方式・服務流程

二、案例討論與反饋
模擬個案・分組討論・討論記錄頁

三、數據分析與策略研討
指標・全市數據・自我診斷工作單・行動承諾卡・討論記錄頁

四、會後帶回
七個流程優化做法・參考資料

開場｜10:00–10:05

今日議程 09:30–12:30

時間	議程	主持人／主講者	今天在簡報裡
09:30–10:00	報到	—	掃描加入 LINE 社群
10:00–10:05	開場與人員介紹	衛生局	—
10:05–11:15	微觀 **共學主題報告（一）** 案例討論與反饋	專家委員 共學團體講師主持人	個案介紹 10′ → 分組討論 28′ → 兩組報告 14′ → 專家回饋 15′ → 小結 3′
11:15–11:20	休息	—	—
11:20–12:15	宏觀 **共學主題報告（二）** 數據分析與策略研討	專家委員 共學團體講師主持人	數據介紹 10′ → 分組討論 25′ → 兩組報告 10′ → 專家回饋與總回饋 10′
12:15–12:30	滿意度調查、大合照	—	掃描滿意度問卷

產出：每組一張討論單（案例：加在第幾天的接觸點；數據：缺口 → 原因 → 改善）；每個單位一張 30 天行動承諾卡。

開場｜10:00–10:05

人員介紹與分組

主辦單位
基隆市衛生局

協辦單位
台灣生活復能健康促進協會

專家委員
倪麗芬 副教授
長庚科技大學

主持人
鍾孟修 職能治療師
台灣生活復能健康促進協會 理事長

第一組
約 5 個單位
組長：_____
記錄：_____

第二組
約 5 個單位
組長：_____
記錄：_____

組長：帶討論、控時，並上台報告
記錄：寫討論單，報告時協助補充
報告順序：第一組完整報告，第二組只補充第一組沒提到的內容

開場｜進行方式

兩個單元，同一套節奏

微觀 共學主題報告（一）案例討論與反饋・70 分鐘

10:05	**個案介紹** 10′	胡女士的案例：初評到後測
10:15	**分組討論** 28′	兩組各自討論 4 個問題
10:43	**第一組報告** 8′	完整報告
10:51	**第二組報告** 6′	只補充第一組沒提到的內容
10:57	**專家回饋** 15′	倪麗芬副教授
11:12	**主持人小結** 3′	案例教我們的五件事

宏觀 共學主題報告（二）數據分析與策略研討・55 分鐘

11:20	**數據介紹** 10′	全市指標、漏斗、新開案分析
11:30	**分組討論** 25′	找缺口，每個單位寫 30 天行動承諾卡
11:55	**第一組報告** 6′	完整報告
12:01	**第二組報告** 4′	只補充第一組沒提到的內容
12:05	**專家回饋** 10′	第二單元回饋＋今天的總回饋

開場｜注意事項

共學活動注意事項

計畫規定（115 年長者內在能力檢測推動計畫）

1. 共學活動屬國健署與衛生局辦理的**學習成長活動**，參與計畫的服務人員須配合參加。
2. 服務資格效期 2 年。展延須在 1 年內完成**繼續教育 150 分鐘**，本場是否認列以主辦單位公告為準。
3. 執行院所應有**品質管理機制**：服務人員自我管理（收案、評估、紀錄、上傳、進度），加上主管監督（抽查、回饋、改善追蹤）。
4. 應建立**轉介（介入）模式**：轉介流程與原則、收案與介入內容、結果回饋方式、功能變化追蹤；訪查時會抽驗案件。

今天的現場約定

1. **個資去識別**：個案只講化名與年齡層，不拍攝、不外傳量表與名冊。
2. 數據以**單位代碼**呈現。談流程卡在哪裡，不談排名。
3. 請對照**自己單位的數據**：評估數、首次評估數、初評異常、複評、介入與轉介、追蹤、後測。
4. 分**兩組**、每組約 5 個單位，各選**組長**與**記錄**。第二組報告只補充第一組沒提到的內容。
5. 簽到、議程、討論紀錄、照片與行動承諾卡，會後一併留存備查。

規定來源：國健署規定，見各縣市 115 年計畫須知（花蓮縣衛生局 114.12、臺中市衛生局需求說明書）。如有異動，以國健署函文公告為準。

開場｜共同語言

115 年服務流程：從初評到後測

01 · Day 0

前置說明

- 65 歲以上（原住民 55 歲）
- 距前次評估滿 1 年；排除長期臥床
- 簽同意書：營養、認知異常轉介勾選
- 協助註冊 LINE「長者量六力」

02 · Day 0

初評 6 項

A 認知・B 行動・C 營養
D 視力・E 聽力・F 憂鬱

03 · Day 0

用藥＋社會照護與支持

初評**任 1 項異常**就要接續評估

04

複評

- A → BHT 或 AD8
- B → SPPB
- C → MNA-SF
- F → GDS-15
- D、E 異常 → 轉介，**不複評、不後測**

05

個人介入計畫

至少 1 項：居家健康管理、社區據點、轉介醫療、長照中心、單位直接介入、失智共照中心

06 · ≥1 個月

追蹤

評估滿 1 個月起至後測當日；電訪或其他方式，填「追蹤表單（含轉介）」

07 · 3–6 個月

後測

用**同一份複評量表**（認知須與原本 BHT／AD8 相同）；用藥、社會支持異常者一併後測

每月上傳「成人預防保健暨慢性疾病防治資訊系統—長者功能評估」；年底最後上傳日依各縣市公告。追蹤表單與量表為 114 年 10 月修訂版。

依國健署 ICOPE 長者內在能力檢測量表（114.10 修訂）與 115 年計畫須知整理。

共學主題報告（一）案例討論與反饋｜10:05–11:15

微觀

MICRO · 機構版（醫療人員）· 一位長輩的 134 天

跟著一個案例走完一次服務，看長輩怎麼變化，也看單位的介入幫了什麼。

初評	複評與介入	追蹤	再評（後測）
Day 0・114/04/01	Day 0・同一天完成	Day 42・面訪	Day 134・約 4.5 個月

微觀｜個案簡述

認識胡女士：93 歲，人工髖關節置換術後

年齡性別	93 歲女性
身分	榮民；社會福利第三類；身障第二類
病史	高血壓、高血脂、胃食道逆流；雙眼白內障術後（102 年）；左肩（111 年）、右肩（105 年）骨折術後；腰椎 L4–5 椎間盤突出術後（80 年）
主訴	右髖走路疼痛多年，藥物控制仍痛、無法久走。診斷右髖退化性關節炎，113/6/27 右側全人工髖關節置換
長照	114/3/25 開始長照復能服務，目標是改善行走

日常功能

- 聽力差，要靠近、調大音量才能對話
- 沐浴、更衣、如廁可自理但吃力，無大小便失禁
- 家中用助行器，外出坐輪椅；膝蓋痛，幾乎每天貼藥布
- 自己管理藥物；媳婦發現到了領藥時間仍常有剩藥
- 會用手機看影片；在媳婦陪同下會簡單備餐

案例資料改編自案例分享示範，部分內容已調整，僅供教學討論。

微觀｜家庭與照顧

家庭與照顧：她不想麻煩任何人

家庭概況

喪偶，育有 2 女 1 子。與兒子、媳婦、孫子同住，**媳婦是主要照顧者**。兩個女兒住板橋、桃園，常回來帶她外出用餐。

照顧上的難題

個性獨立、不願麻煩人。媳婦願意接送她去上課，她不要；女兒想增加長照服務頻率，她也不要。媳婦想外出也要先徵得她同意，表示**有照顧壓力**。

時間	發生的事
Day −7 · 114/3/25	開始長照復能服務
Day 0 · 114/4/01	初評、複評、個人介入計畫（同一天完成）
Day 42 · 114/5/13	追蹤（面訪）：醫療檢查、輔具到位；社區據點沒有去
Day 134 · 114/8/13	後測：SPPB 6 → 8；已配戴助聽器

規定窗口：追蹤＝評估滿 1 個月起至後測當日；後測＝評估後 3～6 個月（7/01–10/01）。

微觀｜114/04/01 初評

初評：認知、行動、聽力三項異常

A	認知	日期✓・地點✓・3 項物品回憶未全部答對	☑ 異常
B	行動	椅子起身 5 次 **16.6** 秒（>12 秒）	☑ 異常
C	營養	體重沒有減輕、食慾正常（BMI 22.8）	☐ 異常
D	視力	戴眼鏡遠、近距離皆通過；高風險眼科調查皆「否」	☐ 異常
E	聽力	氣音測試無法正確複誦	☑ 異常
F	憂鬱	兩題皆「否」	☐ 異常

停一下：下一步要做哪些評估？

答案於現場說明，也可在網頁版查看。

微觀｜114/04/01 同一天複評

同一天複評：認知排除，行動受限，再加上用藥與社會支持

A	BHT	定向 4/4・登錄 4/5・流暢 8 種（1 分）・回憶 2/5	**11**/16	● ≤9 才異常
B	SPPB	平衡 1（並排 10 秒、半前後 3 秒、前後 1 秒）・步行 4 公尺 5.61 秒 3・起身 16.6 秒 2	**6**/12	● <10 受限
E	聽力	初評未通過，直接轉介		● 轉介
Rx	用藥	有使用止痛藥、助眠藥；未達 10 種；無明顯副作用		● 需諮詢
S	社會支持	屋內行動、如廁、洗澡吃力；沒有固定社交活動；近半年無跌倒		● 需支持

做得好

初評、複評、介入計畫在同一天完成，異常項目當天確認，沒有流失。

邏輯要補

原紀錄的異常項目只寫「行動、聽力、用藥」，但**社會照護與支持**也勾了「是」，應列入異常，排入追蹤與後測。

BHT 11 分（滿分 16），認知排除異常；原本的記憶抱怨仍可在追蹤時留意。

微觀｜114/04/01 個人介入計畫

個人介入計畫：每個異常項目都有對應

異常項目	介入內容	對應的介入類型（115 須知）
行動	衛教（紙本／線上保健教材）；長照復能—居家職能治療（3/25 已開始）；輔具服務點（輔具中心）；一般社區據點	居家健康管理・連結長照・連結社區據點
聽力	衛教；轉介耳鼻喉科；華科基金會（助聽器資源）	轉介醫療院所・連結社區資源
用藥	衛教；向原處方醫師諮詢	轉介醫療院所
社會照護與支持	衛教；原有長照服務（陪伴外出、陪同運動）；一般社區據點	連結長照・連結社區據點

優點：每個異常項目都有對應介入，也善用了原本就有的長照服務。

先想一想：她不想麻煩媳婦、不想去上課。這張計畫裡，哪一項最可能做不到？媳婦的照顧壓力有被處理嗎？

微觀｜114/05/13 追蹤（第 6 週・面訪）

追蹤：醫療與輔具到位，社區據點沒有去

追蹤表單選項	紀錄
D｜至醫療院所進一步檢查（耳鼻喉科）	● 已勾選
F｜配戴輔具或調整輔具使用狀況	● 已勾選
A｜依衛教教材執行健康行為	● 未勾選
E｜至社區據點接受介入活動或課程	● 未勾選
G｜運用社福中心資源	● 未勾選
H｜運用照管中心資源（提出申請、照專評估）	● 未勾選
I｜對處置建議未採取行動	● 未勾選

解讀
聽力檢查與輔具已經到位。社區據點沒有去，和她「不想麻煩人」一致。向原處方醫師諮詢用藥的結果，沒有記錄。

關鍵問題
追蹤只勾了 2 項。沒勾的項目，是沒做、沒問，還是沒記？

時間：評估後第 6 週，符合「滿 1 個月起」的追蹤規定。

微觀｜114/08/13 後測（約 4.5 個月）

後測：SPPB 6 → 8，平衡與起身進步最多

SPPB 總分 0–12 分，≥10 正常



複評 **6** 後測 **8**

椅子起身 5 次 秒，≤12 正常（越低越好）



複評 **16.6** 後測 **13.1**

步行 4 公尺 秒，<4.82 得滿分（越低越好）



複評 **5.61** 後測 **5.18**

半前後站 秒，站滿 10 秒得分



複評 **3** 後測 **8**

前後站 秒，≥10 秒得 2 分



複評 **1.0** 後測 **3.5**

並排站 秒，站滿 10 秒得分



複評 **10** 後測 **10**

聽力：已配戴助聽器，並做聽力訓練。聽力不需後測，但成果要記錄。

社會照護與支持：新申請輔具及無障礙規劃、長照居家陪伴運動及外出。

還缺一項：用藥評估異常，後測時應一併評估，案例資料沒有記錄。

微觀｜介入幫了什麼

哪些介入可能發揮了幫助？

介入	行動 SPPB +2	聽力 戴上助聽器	用藥 未記錄	社會支持 新申請資源
長照復能（居家職能治療）	●	—	—	○
輔具中心（輔具評估）	○	—	—	●
耳鼻喉科＋華科基金會	—	●	—	—
向原處方醫師諮詢用藥	○	—	?	—
長照陪伴外出、陪同運動	○	—	—	●
一般社區據點（沒有去）	—	—	—	—

● 主要可能貢獻　○ 間接可能貢獻　— 無明顯關聯　? 結果未記錄

判讀要小心

- 髖關節置換術後約 10 個月，本來就在恢復期
- 長照復能在初評前一週就開始，很難分出是哪個介入的功勞
- 助聽器的成效看配戴時數與溝通改善，量表看不出來

單位可以做的：追蹤時記錄「已在使用的服務」與「同期發生的事」，判讀時才分得清楚。

媳婦的照顧壓力，沒有出現在任何一項介入裡。

微觀｜分組討論 10:15–10:43

分組討論：如果胡女士是你們單位的個案

Q1 行動：SPPB 6 → 8，仍未達 10。下肢疼痛、功能與預防跌倒，下一步怎麼做？

復能、運動、止痛用藥、輔具與居家環境

Q2 聽力：已經戴上助聽器，怎麼讓她願意持續戴、持續訓練？還需要轉介誰？

Q3 資源：她不想麻煩人，拒絕上課、拒絕增加長照。社會資源、非醫療資源、輔具與無障礙資源怎麼用？

也想想媳婦的照顧壓力

Q4 流程：從初評到後測，哪一站可以做得更完整？

異常清單、追蹤紀錄、用藥後測、後測時間

組長：帶討論、控時，並上台報告
記錄：寫討論單，報告時協助補充
產出：每題寫下一個具體做法（誰、何時、轉介到哪裡）

組別：☐ 第一組　☐ 第二組　組長：＿＿＿＿＿＿　記錄：＿＿＿＿＿＿　單位：＿＿＿＿＿＿

一、討論的記錄重點

可依題號記錄：Q1 行動與預防跌倒／Q2 聽力與助聽器／Q3 資源運用與照顧者／Q4 流程哪一站可以更完整

二、相關記錄內容

寫下每題的具體做法（誰、何時、轉介到哪裡），可標在時間軸上；也可記下第二組的補充與專家回饋重點。



微觀｜主持人小結 11:12–11:15

案例反饋：胡女士的 134 天，教我們五件事

1. **同一天完成初評、複評與介入計畫**
   異常項目當天確認，長輩不會在中間流失。
2. **異常清單要完整**
   社會照護與支持勾了「是」，就要列入異常，排入追蹤與後測。
3. **追蹤要問到每一項轉介**
   社區據點沒去、用藥諮詢沒有結果。表單沒勾，不代表沒有問題。
4. **後測要完整**
   行動用 SPPB；用藥與社會照護與支持異常者，也要一併後測。
5. **照顧者也是介入對象**
   媳婦的照顧壓力，可以連結家庭照顧者支持服務。

介入有幫助的地方
長照復能與輔具讓行動進步（SPPB 6 → 8）；耳鼻喉科與基金會讓她戴上助聽器。

休息後：把這些卡點放到全市數據裡，看看有多常見。

共學主題報告（二）數據分析與策略研討｜11:20–12:15

宏觀

MACRO · 30 個單位 · 9,454 筆評估

剛才案例裡的卡點，放到全市數據裡有多常見？把數據攤開，看流程在哪一段流失。

找得到嗎？	接得住嗎？	追得到嗎？	找得到新的嗎？
評估效能	介入率・轉介率	追蹤・後測	新開案分析

宏觀｜指標定義

先對齊：每個指標的分子與分母

評估效能｜找得到嗎

初評異常率 = 初評任 1 項異常人數 ÷ 評估人數

複評完成率 = 完成複評人數 ÷ 初評異常人數

異常率 = 確認異常人數（複評異常＋視聽異常） ÷ 評估人數

篩選線 <10%

接得住嗎

介入率 = 有個人介入計畫人數 ÷ 異常人數

篩選線 <50%

轉介率 = 轉介他單位接手人數 ÷ 異常人數

轉介到位率 = 確認已到位人數 ÷ 轉介人數

追得到嗎

追蹤率 = 完成追蹤人數 ÷ 複評異常人數

後測率 = 完成後測人數 ÷ 已到後測期的應後測人數　篩選線 <30%

找得到新的嗎

新開案比 = 首次評估人數 ÷ 評估人數

首次評估者：110–114 年未曾接受評估。

篩選線＝衛生局「2026 機構訪查篩選表」挑選訪查對象用的門檻，用來找出需要協助的流程，不是績效排名。

宏觀｜總覽

30 個單位、9,454 筆評估的整體樣貌

15.0%
初評異常率
1,414 / 9,454

82.9%
複評完成率
至少 239 人未複評

11.3%
異常率
1,073 / 9,454

89.0%
介入率
959 / 1,078

57.7%
後測率
187 / 324（已到期）

單位類型	單位數	評估數	複評完成率	異常率	介入率	後測率
醫院	6	2,426	85.5%	10.8%	97.7%	80.2%
衛生所	7	5,557	86.7%	11.2%	85.4%	61.1%
診所	13	1,171	70.3%	15.0%	90.6%	15.4%
藥局	4	300	資料不足	4.7%	71.4%	100.0%
全市	**30**	**9,454**	**82.9%**	**11.3%**	**89.0%**	**57.7%**

觸及篩選線的單位

17 / 30 家至少觸及一條

異常率 <10%：**12** 家・介入率 <50%：**2** 家・後測率 <30%：**7** 家

另有 2 家因初評異常未複評，無法計算。

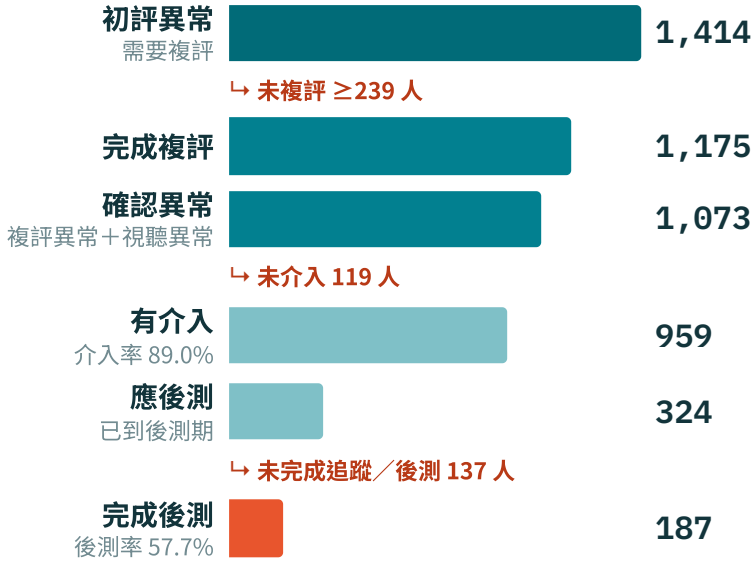
全國參考

114 年全國約 35.5 萬名長者受檢；2026 年 8 月國健署指出，約每 4 位受檢長者有 1 位至少一項能力需要關懷。

資料：2026 機構訪查篩選表彙整（醫院 6、衛生所 7、診所 13、藥局 4）。各單位分母定義略有差異，加總僅供討論；藥局複評欄位資料不足未計。

宏觀｜流程效能

漏斗看流失：長輩在哪一段掉出去？



三個流失點

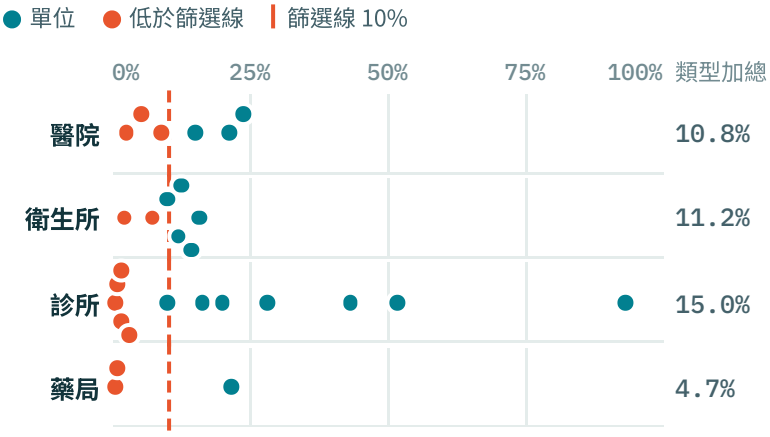
1. 初評異常 → 複評：至少 **239** 人沒有複評
2. 異常 → 介入：**119** 人沒有介入紀錄
3. 到期 → 後測：**137** 人未完成追蹤或後測

另有 **131** 人**還沒到後測期**。年底前要排進行程，避免掉進下一個流失點。

漏斗前兩層以 1,414 人為 100% 寬度；評估總數 9,454 人未畫出，以免壓扁其他層。

宏觀｜評估效能

評估效能：異常率太低、太高都要看



右欄為該類型加總異常率。

偏低（12 家 <10%）可能代表

- 施測或判讀較寬鬆、漏記
- 初評異常後未複評就結案
- 收案集中在健康、活躍的長輩

偏高（3 家 ≥40%）可能代表

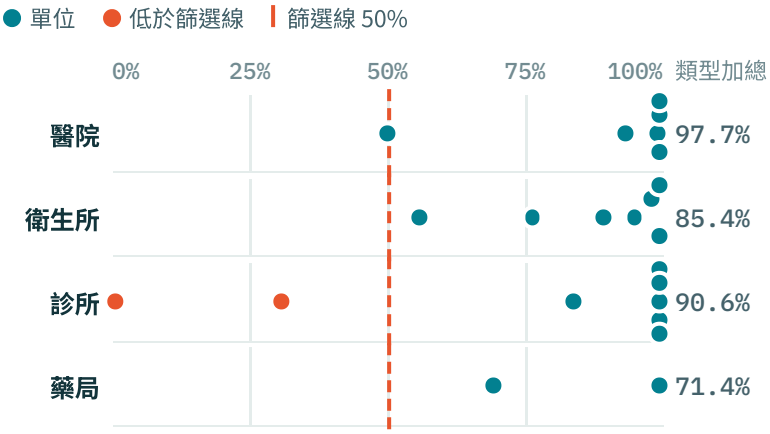
- 收案集中在高風險門診病人
- 把「初評異常」直接當「確認異常」

診所：找得到，接不太住

初評異常率 23.0% 最高，複評完成率 70.3% 最低。

宏觀｜介入率

介入率 89.0%，大多數單位都「有做」



低於或貼近篩選線

- 診所 M：4/13（30.8%）
- 診所 J：0/1（視力異常 1 案）
- 醫院 F：2/4（50.0%）

先檢查分母

衛生所 F 的分母用了初評異常數；若改用確認異常數，介入率約 67.6%。

下一個問題

介入率高，不等於長輩真的被接手。只給一張衛教單張，也算介入。

宏觀｜轉介率

轉介率：介入有沒有「交到下一雙手」

個人介入計畫的 6 種樣子（115 須知）

介入類型	誰接手
指導居家健康管理	長輩自己、家屬
評估單位直接介入	本單位課程或訓練
連結社區據點	據點、營養推廣中心、輔具點
轉介醫療院所	高齡整合門診、專科
連結長照管理中心	長照 2.0
連結失智共照中心	共照中心個管師

後四類需要其他單位接手，計入轉介率。

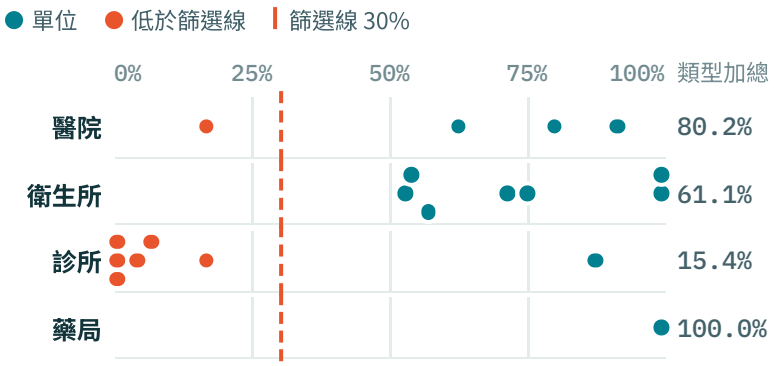
請各單位帶回去算（篩選表目前沒有轉介欄位）

本單位近 6 個月	人數		比率
確認異常人數	____		分母
只做居家健康管理（單張、衛教）	____		____%
轉介他單位接手	____	轉介率	____%
已確認到位（有就診、有上課、有收案）	____	到位率	____%
對方有回饋結果	____	回饋率	____%

建議下次資料收集加入「轉介人數」「到位人數」兩欄，才看得出介入的深度。

宏觀｜追蹤與後測

後測率：診所 15.4%，是全市最大的缺口



類型	未完成追蹤／後測	尚未到後測期
醫院	19	38
衛生所	63	31
診所	55	55
藥局	0	7
全市	**137**	**131**

7 家低於 30%，其中 6 家是診所。共同點：異常個案多，但沒有人專責排後測。

窗口管理

- 後測窗口：評估後 3～6 個月
- 介入計畫訂好當天，就約好後測日
- 年底上傳截止前 1 個月，盤點「已到期未後測」名單

跨年規定：114 年評估個案可在 115 年完成追蹤與後測。115 年個案是否比照，以 116 年須知為準。

宏觀｜新開案

新開案的分析過程：五個步驟

STEP 1

定義

- 首次評估者：110–114 年未曾評估
- 首次評估初評費 150 元，非首次 100 元
- 再評資格：距前次評估滿 1 年

STEP 2

拉資料

- 從系統下載本年度個案明細
- 標記首次／非首次
- 標記來源：門診、慢箋、社區活動、LINE 自評、他單位轉介

STEP 3

分層比較

- 首次 vs 非首次的初評異常率
- A–F 各面向異常分布
- 年齡層 65–74／75–84／85+

STEP 4

找缺口

- 哪些長輩還沒被評到？
- 75 歲以上少就醫者、獨居、行動不便到不了院所
- 非慢病門診的長輩

STEP 5

定策略

- 門診系統跳提醒
- 慢箋回診順便評估
- 社區活動設站、與據點合作
- 訂每月新開案目標並追蹤

分析表範本（請帶自己單位的數字）

	人數	初評異常率	最多的異常面向	主要來源
首次評估	____	____%	____	____
非首次評估	____	____%	____	____

判讀提示

如果首次與非首次的異常率差不多，而且來源都是同一個門診，可能一直在評同一群相對健康的長輩。新開案要往「還沒進來的人」找。

宏觀｜工具

單位自我診斷工作單

請填入你們單位的人數，再依右側公式計算各項指標（網頁版可自動計算）。

評估人數

首次評估人數

初評異常人數

完成複評人數

確認異常人數

有介入人數

轉介他單位人數

確認到位人數

完成追蹤人數

已到期應後測人數

完成後測人數

新開案比	首次評估 ÷ 評估	_____%
初評異常率	初評異常 ÷ 評估	_____%
複評完成率	完成複評 ÷ 初評異常	_____%
異常率	確認異常 ÷ 評估	_____%
介入率	有介入 ÷ 確認異常	_____%
轉介率	轉介 ÷ 確認異常	_____%
轉介到位率	到位 ÷ 轉介	_____%
追蹤率	完成追蹤 ÷ 確認異常	_____%
後測率	完成後測 ÷ 到期應後測	_____%

宏觀｜分組討論 11:30–11:55

策略研討：找出你們單位的最大缺口

Q1 對照漏斗，你們單位最大的流失在哪一段？
未複評／未介入／未追蹤／未後測／新開案太少

Q2 造成缺口的流程原因是什麼？
從人力、時間、場地、系統、長輩與家屬端各想一個

Q3 你們的「介入」裡，有多少只是給衛教單張？
估一個比例，並說出一個真的交到下一雙手的例子

Q4 下個月可以先改的一件事是什麼？
每個單位填一張 30 天行動承諾卡（下一頁）

組長：帶討論、控時，並上台報告
記錄：寫討論單（缺口 → 原因 → 改善）
產出：每個單位一張 30 天行動承諾卡

宏觀｜分組討論・行動承諾

30 天行動承諾卡

單位

例：○○診所

要改善的指標

例：後測率

現況

例：15%（1/7）

30 天後目標

例：30%

具體做法（誰、何時、怎麼做）

例：介入計畫當天由護理師約好後測日，排第 4 個月；每週五核對到期名單

檢核日期

例：11/30

需要衛生局協助的事

例：據點名單、共照中心窗口

寫法提醒

- 只選一個指標
- 目標要能在 30 天內看到
- 做法寫到「誰」和「哪一天」

這張卡會在下一次訪查或共學時一起回顧。

組別：☐ 第一組　☐ 第二組　組長：＿＿＿＿＿＿　記錄：＿＿＿＿＿＿　單位：＿＿＿＿＿＿

一、討論的記錄重點

可依題號記錄：Q1 最大的流失段／Q2 流程原因／Q3 介入只給單張的比例／Q4 下個月先改的一件事

二、相關記錄內容

整理缺口、原因與改善做法；也可記下需要衛生局協助的事與專家回饋重點。

缺口	原因	改善做法（誰、何時）

會後帶回

會後帶回：七個流程優化做法

卡點（宏觀／微觀）	改善做法	改善指標
初評異常沒有當天複評 全市 ≥239 人（胡女士當天就完成）	異常當天完成複評；做不到就發複評預約卡，7 天內完成	複評完成率
轉介後沒人確認 胡女士：據點沒去、用藥諮詢無結果	第 2 週打關懷電話確認「有沒有去」；滿 1 個月做正式追蹤，逐項記錄每個轉介的結果	到位率・追蹤率
異常清單不完整 胡女士：社會支持未列入、用藥未後測	逐項對照異常定義；用藥、社會照護與支持異常者也列入，並一併後測	追蹤率・後測率
後測卡在窗口尾端 診所後測率 15.4%	介入計畫訂好當天就約後測日，排在第 4 個月，留重排空間	後測率
介入多半只給單張	每位異常長輩至少一項「有人接手」的介入	轉介率
只看年度報表	每月看一次自己的漏斗；主管每月抽查 5 案並回饋	全部
新開案靠臨櫃遇到	門診系統提醒、慢箋回診順評、社區設站、LINE 自評異常轉院評	新開案比

附錄

參考資料

計畫須知 花蓮縣衛生局《115 年長者內在能力檢測推動計畫 計畫須知》，114 年 12 月。開啟 PDF

需求說明 臺中市政府衛生局《115 年長者內在能力檢測推動計畫 需求說明書》，含服務人員資格規定。開啟 PDF

量表 國民健康署《長者內在能力檢測量表》，114 年 10 月修訂。開啟 PDF

工作手冊 國民健康署《預防及延緩失能之長者功能評估服務試辦計畫 工作手冊》，110 年 5 月。開啟 PDF

新聞稿 國民健康署〈全臺醫療單位齊心 陪長輩「量六力」〉，2025 年 11 月 26 日。開啟網頁

報導 工商時報〈「量六力」揪失能警訊 每 4 名長者就有 1 人需注意〉，2026 年 8 月。開啟網頁

數據 2026 機構訪查篩選表（衛生局內部資料，本簡報已去識別化為單位代碼）。

各項規定以國民健康署最新函文公告為準。案例改編自案例分享示範，部分內容已調整，僅供教學討論。